老年人健康体检报告

报告编号： GY20250315-002
体检日期： 2025年03月15日
报告日期： 2025年03月18日

一、基本信息

项目	内容
姓名	张建民
性别	男
年龄	72岁
身份证号	******
联系电话	1381234
既往病史	高血压病史10年，规律服用降压药
体检机构	XX市老年健康管理中心

二、体格检查

检查项目	检查结果	参考范围	单位	提示
血压（收缩压/舒张压）	145 / 92	< 140 / < 90	mmHg	偏高
心率	72	60-100	次/分	正常
身高	170	-	cm	-
体重	68	-	kg	-
BMI	23.5	18.5-24.0	kg/m²	正常

三、实验室检查

3.1 血常规

项目	结果	参考范围	单位	提示
白细胞计数	5.8	3.5-9.5	10^9/L	正常
红细胞计数	4.6	4.3-5.8	10^12/L	正常
血红蛋白	138	130-175	g/L	正常
血小板计数	210	125-350	10^9/L	正常

3.2 肝功能与肾功能

项目	结果	参考范围	单位	提示
谷丙转氨酶	28	10-40	U/L	正常
谷草转氨酶	32	10-40	U/L	正常
肌酐	78	59-104	μmol/L	正常
尿素氮	5.6	3.2-7.1	mmol/L	正常
尿酸	360	208-428	μmol/L	正常

3.3 血脂与血糖

项目	结果	参考范围	单位	提示
总胆固醇	6.2	<5.2	mmol/L	**偏高**
甘油三酯	1.7	<1.7	mmol/L	正常高限
高密度脂蛋白	1.0	>1.0	mmol/L	偏低（临界）
低密度脂蛋白	3.8	<3.4	mmol/L	**偏高**
空腹血糖	6.8	3.9-6.1	mmol/L	**偏高**
糖化血红蛋白	6.0	<6.5	%	正常（需监测）

3.4 尿常规

项目	结果	参考范围	提示
尿糖	阴性	阴性	正常
尿蛋白	阴性	阴性	正常
尿酮体	阴性	阴性	正常

四、辅助检查

4.1 心电图

检查所见： 窦性心律，心率72次/分，ST段轻度压低（V5、V6导联），T波低平。
结论： 窦性心律，ST-T改变（提示心肌缺血可能，建议心内科进一步评估）。

4.2 腹部B超

检查所见： 肝脏形态大小正常，回声增强、细密，后场衰减；肝内管道结构欠清。胆、胰、脾、双肾未见明显异常。
结论： **轻度脂肪肝。**

4.3 骨密度检测（双能X线）

检查部位： 腰椎L1-L4，左侧股骨颈
T值： -2.8
结论： **骨质疏松**（T值 ≤ -2.5）。

五、异常结果汇总

1. **血压偏高**：145/92 mmHg
2. **血脂异常**：总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇升高
3. **空腹血糖升高**：6.8 mmol/L（空腹血糖受损）
4. **心电图ST-T改变**：可疑心肌缺血
5. **轻度脂肪肝**
6. **骨质疏松**（T值 -2.8）

六、健康评估与建议

6.1 综合评估

受检者为72岁男性，有高血压病史，目前存在**血压控制不理想、血脂代谢紊乱、糖调节受损、骨质疏松及心肌缺血风险。**需积极干预，预防心脑血管事件及骨折风险。

6.2 具体建议

1. 血压管理

- 规律服用降压药，每日监测血压（目标 < 140/90 mmHg）。
- 低盐饮食（每日食盐 < 5g），避免腌制食品。

2. 血脂与血糖控制

- 低脂、低糖、高纤维饮食，减少动物内脏、油炸食品。
- 增加全谷物、蔬菜、深海鱼类摄入。
- 空腹血糖受损，建议进一步行**口服葡萄糖耐量试验**，内分泌科随访。

3. 心血管系统

- 心内科就诊，评估是否需抗心肌缺血治疗（如硝酸酯类药物或改善冠脉供血）。
- 定期复查心电图，必要时行冠脉CTA或负荷试验。

4. 脂肪肝管理

- 控制体重，增加有氧运动（每周≥150分钟，如快走、太极拳）。
- 戒酒，避免高果糖饮料。

5. 骨质疏松防治

- 补充钙剂（每日600-1200mg）和维生素D（每日800-1000 IU）。
- 适当进行负重运动（如散步、站桩），预防跌倒。
- 根据骨密度结果，医生评估是否使用抗骨质疏松药物（如双膦酸盐）。

6. 定期复查建议

- 每3个月复查血压、血脂、空腹血糖。
- 每6-12个月复查心电图、骨密度。
- 每年复查腹部B超及肝肾功能。

七、重要提醒

- 本报告仅反映本次体检时的身体状况，不能替代医生的临床诊断。
- 如有头晕、胸闷、骨痛等不适，请及时就医。
- 建议携带本报告至全科或老年科门诊，制定个体化治疗方案。

医生签名： 李敏（副主任医师）
审核日期： 2025年03月18日

> 报告最终解释权归XX市老年健康管理中心所有
> 电子报告与纸质版具有同等效力